Приложение № ___
к Приказу Министра
здравоохранения
Республики Узбекистан
№____ от «____» _____2025 г.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР КАРДИОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ «ИНФЕКЦИОННЫЕ ЭНДОКАРДИТЫ»

ТАШКЕНТ – 2025

"УТВЕРЖДАЮ"
Министр здравоохранения
Республики Узбекистан
А.А. Худаяров
_____
«____»_____2025 г .

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ «ИНФЕКЦИОННЫЕ ЭНДОКАРДИТЫ»

ТАШКЕНТ – 2025



НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ «ИНФЕКЦИОННЫЕ ЭНДОКАРДИТЫ»

ТАШКЕНТ 2025

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЭНДОКАРДИТЫ

Кодирование по МКБ 10:	**Название нозологии:**	**Специалисты, привлекаемые по нозологии для диагностики и лечения в амбулаторных условиях**		**Специалисты, привлекаемые по нозологии для диагностики и лечения в стационарных условиях**	
		Основные курирующие специалисты	Дополнительные курирующие специалисты	Основные курирующие специалисты	Дополнительные курирующие специалисты
I33	Острый и подострый эндокардит:	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клинический фармаколог
I33.0	Острый и подострый инфекционный эндокардит	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клинический фармаколог
I33.9	Острый эндокардит неуточненный;	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог,

					нефролог клинический фармаколог
I38	Эндокардит, клапан не уточнен;	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клинический фармаколог
I39	Эндокардит и поражения клапанов сердца при болезнях, классифицированных в других рубриках:	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клинический фармаколог
I39.2	Поражения трехстворчатого клапана при болезнях, классифицированных в других рубриках;	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клинический фармаколог
I39.1	Поражения аортального клапана при болезнях, классифицированных в других рубриках;	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог,

					нефролог клинический фармаколог
I39.0	Поражения митрального клапана при болезнях, классифицированных в других рубриках;	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клинический фармаколог
I39.3	Поражения клапана легочной артерии при болезнях, классифицированных в других рубриках;	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клинический фармаколог
I39.4	Множественные поражения клапанов при болезнях, классифицированных в других рубриках;	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клинический фармаколог
I39.8	Эндокардит, клапан не уточнен, при болезнях, классифицированных в других рубриках;	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог,

					нефролог клинический фармаколог
T85.7	Инфекция и воспалительная реакция, обусловленная другими внутренними протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами.	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клинический фармаколог

Кодирование по МКБ 11:	**Название нозологии:**	**Специалисты, привлекаемые по нозологии для диагностики и лечения в амбулаторных условиях**		**Специалисты, привлекаемые по нозологии для диагностики и лечения в стационарных условиях**	
		Основные курирующие специалисты	Дополнительные курирующие специалисты	Основные курирующие специалисты	Дополнительные курирующие специалисты
BA80	Острый эндокардит	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клинический фармаколог
BA80.0	Острый инфекционный эндокардит	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог,

					нефролог клинический фармаколог
BA80.1	Острый эндокардит при болезнях, классифицированных в других рубриках:	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клинический фармаколог
BA80.9	Острый эндокардит неуточнённый	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клинический фармаколог
BA81	Хронический эндокардит	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клинический фармаколог
BA81.0	Хронический инфекционный эндокардит	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог,

					нефролог клинический фармаколог
BA81.1	Хронический эндокардит при болезнях, классифицированных в других рубриках:	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клинический фармаколог
BA81.9	Хронический эндокардит неуточнённый	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клинический фармаколог
BA82	Эндокардит, клапан не уточнён	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клинический фармаколог
BA82.0	Эндокардит, клапан не уточнён	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог,

					нефролог клинический фармаколог
BA83	Эндокардит с поражением клапанов при болезнях, классифицированных в других рубриках;	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клинический фармаколог
BA83.0	Эндокардит при болезнях, классифицированных в других рубриках;	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клинический фармаколог
BA83.1	Эндокардит митрального клапана при болезнях, классифицированных в других рубриках;	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клинический фармаколог
BA83.2	Эндокардит аортального клапана при болезнях, классифицированных в других рубриках;	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог,

					нефролог клинический фармаколог
BA83.3	Эндокардит трикуспидального клапана при болезнях, классифицированных в других рубриках;	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клинический фармаколог
BA83.4	Эндокардит клапана лёгочной артерии при болезнях, классифицированных в других рубриках;	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клинический фармаколог
AB75.6	Кандидозный эндокардит	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клинический фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенционный аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клинический фармаколог

*** при заполнении стандарта обязательно указывают нозологию, ее течение у взрослых, беременных, детей и пожилых людей, а также период заболевания.**

Также не рекомендуется заполнять таблицы, не соответствующие данной нозологии. (Например, если по нозологии не ведется хирургическая практика, не заполняется таблица «ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ», или если в нозологию не входит паллиативное лечение - не заполняется таблица (ПАЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ).

ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ, РЕАБИЛИТАЦИЯ и ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Диагностические мероприятия	Название медицинской услуги	Уровень и вид медицинской помощи					Минимальное количество услуг и исследований	Срок лечения
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
		СВП/СП	МПЦП	Районная (городская) больница	ЛПУ на уровне области	ЛПУ на уровне республики		
Консультации основных специалистов (врачей)	1. Семейный врач	+					После острого неосложнённого эндокардита 1 раз в месяц в течение 3 месяцев	Амбулаторное наблюдение при остром эндокардите 3 месяца, при хроническом эндокардите с ХСН – пожизненно; Стационарное лечение: 10-12 дней*
	2. Кардиолог		+	+	+	+	- После острого неосложнённого эндокардита однократно - после острого осложнённого эндокардита 1 раз в месяц в течение 3 месяцев - при хроническом эндокардите с ХСН и I-II ФК: 2 раза в год; - при хроническом эндокардите с ХСН III-IV ФК 4 раза в год	
	3. Терапевт		+	+				

Примечание: * Продолжительность стационарного лечения зависит от цели госпитализации.
Осмотры специалистов в стационарных условиях проводятся ежедневно.

Консультации дополнительных специалистов (врачей)	**1. ревматолог**			**+**	**+**	**+**		
	2. инфекционист				**+**	**+**		
	3. интервенционный аритмолог					**+**		
	4. фтизиатр		**+**	**+**	**+**	**+**		
	5. эндокринолог		**+**	**+**	**+**	**+**		
	6. пульмонолог			**+**	**+**	**+**		
	7. лор		**+**	**+**	**+**	**+**		
	8. офтальмолог		**+**	**+**	**+**	**+**		
	9. гематолог			**+**	**+**	**+**		
	10. токсиколог			**+**	**+**	**+**		
	11. нейрохирург			**+**	**+**	**+**		
	12. микробиолог			**+**	**+**	**+**		
	13. невропатолог		**+**	**+**	**+**	**+**		
	14. нефролог		**+**	**+**	**+**	**+**		
	15. клинический фармаколог			**+**	**+**	**+**	**По показаниям**	
Примечание: Все осмотры узких специалистов организовываются по показаниям. В стационарных условиях количество осмотров узких специалистов следует проводить в соответствии с клинической ситуацией.								
Основные лабораторные исследования	**1. Общий анализ крови**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**- После острого неосложнённого эндокардита однократно - после острого осложнённого эндокардита 1 раз в месяц в течение 3 месяцев - при хроническом эндокардите с ХСН и I-II ФК: 2 раза в год; - при хроническом**	
	2. Общий анализ мочи							
	3. АЛТ, АСТ, билирубин							
	4. Глюкоза	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**		
	5. Креатинин	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**		
	6. Мочевина	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**		
	7. С-реактивный белок	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**		

	8. Ревматоидный фактор		+	+	+	+	эндокардите с ХСН III-IV ФК 4 раза в год	
	9. Антистрептолизин-О		+	+	+	+		
	10. Посев крови на гемокультуру			+	+	+		
Примечание: если материально-техническая база СВП/СП позволяет оценить острофазные пробы (СРБ, АСЛО и РФ), то ВОП должен проводить эти исследования. Количество лабораторных исследований в стационарных условиях определяется исходя из клинического состояния.								
Дополнительные лабораторные исследования	1. Коагулограмма, АЧТВ		+	+	+	+	По показаниям	
	2. Общий белок			+	+	+		
	3. Альбумин			+	+	+		
	4. Глобулины (α-, β-, γ-фракции)			+	+	+		
	5. Общий билирубин			+	+	+		
	6. Прокальцитонин			+	+	+		
	7. Серологическое исследование на ВИЧ			+	+	+		
	8. Серологические исследования на гепатиты В и С			+	+	+		
	9. Реакция Вассермана (RW)			+	+	+		
	10. Калий			+	+	+		
	11. Натрий			+	+	+		
	12. Тропонин			+	+	+		
	13. D-димер				+	+		
	14. Мозговой натрийуретический пептид			+	+	+		
	15. Группа крови, резус-фактор и антиэритроцитарные антитела		+	+	+	+		
	16. Исследование гемокультуры методом ПЦР			+	+	+		

	17. Серологические исследования: ВИЧ, гепатиты В и С			+	+	+		
	18. Посевы с клапанов сердца (протезов)			+	+	+		
Примечание: Группа крови, гепатиты В и С, тесты на ВИЧ должны быть выполнены пациентам, которым запланированы хирургические вмешательства. Количество лабораторных исследований в стационарных условиях определяется исходя из клинического состояния.								
Основные инструментальные исследования	1. ЭКГ	+	+	+	+	+	- После острого неосложнённого эндокардита однократно - после острого осложнённого эндокардита 1 раз в месяц в течение 3 месяцев - при хроническом эндокардите с ХСН и I-II ФК: 2 раза в год; - при хроническом эндокардите с ХСН III-IV ФК 4 раза в год	
	2. Трансторакальное ЭхоКГ			+	+	+		
	3. Трансэзофагеальное ЭхоКГ				+	+		
	4. МСКТ сердца				+	+		
Примечание: В стационарных условиях количество ЭКГ определяют исходя из клинического состояния.								
Дополнительные инструментальные исследования	1. ЭхоКГ		+	+	+	+	По показаниям	
	2. Рентгенография органов грудной клетки		+	+	+	+		
	3. ЭКГ мониторирование по				+	+		

	Холтеру							
	4. Инвазивная коронарография				+	+		
	5. ЭФИ				+	+		
	6. УЗИ внутренних органов		+	+	+	+		
	7. МРТ сердца с контрастированием				+	+		
	8. Патоморфологические исследования клапанов (протезов) сердца				+	+		
	9. Интралюминальная (интраваскулярная) внутрисердечная ЭхоКГ				+	+		
	10. Катетеризация сердца				+	+		
Примечание: Количество инструментальных исследований в стационарных условиях определяется исходя из клинического состояния.								

Диагностические мероприятия	Название медицинской услуги	Уровень и вид медицинской помощи					Минимальное количество услуг и исследований	Срок лечения
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
		СВП/СП	МПЦП	Районная (городская) больница	ЛПУ на уровне области	ЛПУ на уровне республики		
	1. Шкалы CHA2DS2-VASc и HAS-BLED	+	+	+	+	+	При каждом осмотре	
Примечание: Шкала CHA2DS2-VASc рекомендуется использовать при оценки риска инсульта у пацитов с эндокардитом и ФП. Шкала HAS-BLED рекомендуется для оценки риска кровотечений при применении пероральных антикоагулянтов у больных эндокардитом и ФП.								

(МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ)

Терапевтические мероприятия (основное медикаментозное лечение)		Уровень и вид ПЛАНОВОЙ медицинской помощи					Средняя суточная доза	Курсовая доза
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
Название (международное непатентованное) лекарственного средства	Применение и дозировка лекарственного средства	СВП/СП	МПЦП	Районная (городская) больница	ЛПУ на уровне области	ЛПУ на уровне республики		

Перечень основных противомикробных препаратов имеющих 100% вероятность применения: **А) Пенициллины:** **- Бензилпенициллина натриевая соль** **ампициллин** **Б) Цефалоспорины:** **- Цефазолин** **В) b-лактамы** **Амоксициллин / клавуланат** **Г) сульфаниламиды** **Ко-тримоксазол**	**Бензилпенициллина натриевая соль 250 000-500 000 ЕД каждые 6 часов;; Суточную дозу делят на 4-6 введений.**			**+**	**+**	**+**	**суточная доза 1.000.000-2.000.000 ЕД максимальная – 40.000.000-60.000.000 ЕД в сутки внутривенно**	**зависит от клинического статуса**
	Ампициллин 2 г внутривенно каждые 4 часа.			**+**	**+**	**+**	**Максимальная доза: 12 г/день**	**не менее 4-8 недель**
	Цефазолин от 1 до 1,5 г в / в каждые 6 часов или 2 г в / в каждые 8 часов			**+**	**+**	**+**	**Максимальная доза: 12 г/день**	**не менее 4-6 недель**
	Амоксициллин / клавуланат В зависимости от степени тяжести инфекции, назначают 1000 мг/100 мг каждые 8 часов или 2000/200 мг			**+**	**+**	**+**		
	Ко-тримоксазол ➢ **Сульфометоксазол 4 800 мг/день** ➢ **Триметоприм 960 мг/день (в/в в 4-6 введений)**			**+**	**+**	**+**		
Антибактериальная терапия инфекционного эндокардита, вызванного *Streptococcus* spp. **1. [1]Пенициллино-чувствительные штаммы (МИК<0,125 мг/л) стрептококков ротовой**	**Бензилпенициллин - 12-18 млн. 4-6 введений ЕД, в/в;**			**+**	**+**	**+**		**Стандартная схема терапии, 4 недели** **При поражении протезированных клапанов,**
	Амоксициллин-100-200 мг/кг/сут, в/в 4-6 введений;			**+**	**+**	**+**		
	Цефтриаксон 2 г/сут, в/в			**+**	**+**	**+**		

полости и пищеварительного тракта	или в/м в 1 введение							длительность - 6 недель
	[2]Бензилпенициллин - 12-18 млн. ЕД, в/в, 4-6 введений; или			+	+	+		Стандартная схема терапии, 2 недели
	[2]Амоксициллин- 100-200 мг/кг/сут, в/в, 4-6 введений; или			+	+	+		
	[2]Цефтриаксон + Гентамицин2 г/сут, в/в или в/м в 1 введение +3 мг/кг/сут, в/в или в/м в 1 введение» или			+	+	+		
	[2]Нетилмицин 4-5 мг/кг/сут, в/в в 1 введение;			+	+	+		
У пациентов с аллергией на бета-лактамы	Ванкомицин - 30 мг/кг/сут, в/в в 2 введения;			+	+	+		4 недели При поражении протезированных клапанов - длительность до 6 недель.
2. Штаммы, относительно резистентные к пенициллину (МПК 0,250-2 мг/л)	[3]Бензилпенициллин- 500 000 ЕД каждые 6 часов; или			+	+	+	суточная доза 2 000 000 ЕД; максимальная – 40 000 000-60 000 000 ЕД в сутки в/в	4 недели (нативный клапан) 6 недель и > (протезированный клапан)
	Амоксициллин- 100-200 мг/кг/сут, в/в в 4-6 введения.			+	+	+	Максимальная доза: 12 г/день	
	[4]Цефтриаксон 2 г/сут, в/в или в/м кажые 12-24 часа в течении 4-6 недель.			+	+	+		

	Плюс							
	[5]Гентамицин 3 мг/кг/сут, в/в или в/м в 1 введение.			**+**	**+**	**+**		
У пациентов с аллергией на бета-лактамы	**Ванкомицин - 30 мг/кг/сут, в/в, в 2 введения**			**+**	**+**	**+**		**4 недели (нативный клапан) 6 недель и > (протезированный клапан)**
3. Антибактериальная терапия инфекционного эндокардита, связанного со стафилококками А) нативные клапаны	**(Флу)клоксациллин или оксациллин 12 г/сут, в/в в 4-6 введений; или**			**+**	**+**	**+**		**длительность 4-6 недель.**
	Ко-тримаксозол. Сульфаметоксазол 4800 мг/сут и Триметоприм 960 мг/сут (в/в, 4-6 введений) 1800 мг/сут в 3 введения. плюс			**+**	**+**	**+**		**Длительность: 1 в/в +5 per os**
	Клиндамицин 1800 мг/день в 3 введения.			**+**	**+**	**+**		**Длительность: 1 неделя.**
Пациенты с аллергией на пенициллин, либо метицилин-чувствительные стафилококки.	**Ванкомицин 30-60 мг/кг/сут, в/в в 2-3 введения или**			**+**	**+**	**+**		**длительность 4-6 недель.**
	Даптомицин10 мг/кг/сут, в/в в 1 введение или			**+**	**+**	**+**		
	Ко-тримаксозол + Клиндамицин Сульфаметоксазол 4800 мг/сут и Триметоприм 960 мг/сут (в/в, 4-6 введений) 1800			**+**	**+**	**+**		**Длительность 1 в/в+ 5 per os мг/сут в 3 введения.**
				+	**+**	**+**		
				+	**+**	**+**		

Б) протезированные клапаны **Метициллин-чувствительные штаммы стафилококки**	**Оксациллин 12 г/сут в/в в 4-6 введений;** **+** **Рифампицин 900-1200 мг/сут, в/в или внутрь в 2-3 введения;** **+**			**+**	**+**	**+**		**длительность ≥6 недель.**
	Гентамицин 3 мг/кг/сут, в/в или в/м в 1 введение;			**+**	**+**	**+**		**длительность 2 недели**
Пациенты с аллергией на бета-лакламы, метицилин-чувствительные штаммы стафилококков.	**Ванкомицин 30-60 мг/кг/сут, в/в в 2-3 введения; +** **Рифампицин 900-1200 мг/сут, в/в в 2-3 введения;** **+**			**+**	**+**	**+**		**длительность ≥6 недель**
	Гентамицин 3 мг/кг/сут, в/в или в/м в 1 введение;			**+**	**+**	**+**		**длительность 2 недели**
4. Антибактериальная терапия инфекционного эндокардита, вызванного энтерококками **Штаммы, чувствительные к бета-лактамам и гентамицину**	**[6]Амоксициллин 200 мг/кг/сут, в/в в 4-6 введений;** **+**			**+**	**+**	**+**		**длительность 4-6 недель**
	[6]Гентамицин 3 мг/кг/сут, в/в или в/м в 1 введение;			**+**	**+**	**+**		**длительность 2-6 недель**
	[7]Ампициллин 200 мг/кг/сут, в/в в 4-6 введений; **+** **Цефтриаксон 4 г, в/в или в/м в 2 введения;**			**+**	**+**	**+**		**длительность -6 недель**

	или							
	[8]Ванкомицин 30 мг/кг/сут, в/в в 2 введения + Гентамицин 3 мг/кг/сут, в/в или в/м в 1 введение;			**+**	**+**	**+**		
5. Колхицин[3]	**Колхицин 0,5-1 мг по 1 табл. 1 раз в день**		**+**	**+**	**+**	**+**	**Колхицин 0,5-1 мг по 1 табл. 1 раз в день**	**3-6 месяцев**
6. Глюкокортикостероиды[4]: - Преднизолон	**Преднизолон 30-40 мг в сутки**		**+**	**+**	**+**	**+**	**Преднизолон 30-40 мг в сутки**	**3-6 месяцев**
7. Блокаторы РААС: А) иАПФ: - Эналаприл - Рамиприл - Периндоприл Б) БРА (сартанлар): - Валсартан - Лозартан - Кандесартан - Телмисартан - Азилсартан - Олмесартан	**иАПФ: - Эналаприл 2,5-20 мг 2 раз в день - Рамиприл 2,5-10 мг 1 раз в день - Периндоприл эрбумин 2-8 мг 1 раз в день - Периндопил аргинин 2,5-10 мг 1 раз в день БРА: - Валсартан – 40-320 мг 2 раз в день - Лозартан 25-100 мг 1 раз в деь - Кандесартан 4-32 мг 1 раз в день - Телмисартан 10-80 мг 1 раз в день - Азилсартан 20-80 мг 1 раз в день - Олмесартан 10-40 мг 1 раз в день**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**иАПФ: - Эналаприл 2,5-20 мг - Рамиприл 2,5-10 мг - Периндоприл эрбумин 2-8 мг - Периндопил аргинин 2,5-10 мг БРА: - Валсартан – 40-320 мг - Лозартан 25-100 мг - Кандесартан 4-32 мг - Телмисартан 10-80 мг - Азилсартан 20-80 мг - Олмесартан 10-**	**Длительность терапии зависит от клинического статуса**

							40 мг	
8. АРНИ[5]: - Сакубитрил/Валсартан	24/26 мг (50 мг), 49/51 мг (100 мг) или 97/103 мг (200 мг). По 1 таблетке 2 раза в день (доза подбирается под контролем АД)	+	+	+	+	+	100-400 мг	Длительность терапии зависит от клинического статуса
9. Бета-блокаторы: - Бисопролол - Метопролол - Небивалол - Карведилол	- Бисопролол 2,5-10 мг 1 раз в день - Метопролол сукцинат 25-100 мг 1 раз в день - Небивалол 2,5-10 мг 1 раз в день - Карведилол 3,125-25 мг кунлик дозаси 2-3 раза в день	+	+	+	+	+	- Бисопролол 2,5-10 мг - Метопролол сукцинат 25-100 мг - Небивалол 2,5-10 мг - Карведилол 3,125-25 мг	Длительность терапии зависит от клинического статуса
10. Антогонисты минералокортикоидных рецепторов: - Спиронолактон - Эплеренон	- Спиронолактон 25-50 мг по 1 табл. (капс) 1 раз в день; - Эплеренон 25-50 мг по 1 табл. 1 раз в день.	+	+	+	+	+	- Спиронолактон 25-50 мг - Эплеренон 25-50 мг	Длительность терапии зависит от клинического статуса
11. SGLT2-ингибиторы: - Эмпаглифлозин - Дапаглифлозин	- Эмпаглифлозин 10-25 мг по 1 табл. 1 раз в день; - Дапаглифлозин 10 мг по 1 табл. 1 раз в день.	+	+	+	+	+	- Эмпаглифлозин 10-25 мг по 1 табл. 1 раз в день; - Дапаглифлозин 10 мг по 1 табл. 1 раз в день.	Длительность терапии зависит от клинического статуса

Примечание:

Основная группа противомикробных препаратов применяется или эмпирически или соответственно выявленному возбудителю в монотерапии или комбинации

Существуют дополнительные лекарственные препараты применяемые в комбинации с препаратами основного перечня (менее 100% вероятности применения).

1 Предпочтительно у пациентов, старше 65 лет, с наличием нефропатии и поражением VIII пары черепно-мозговых нервов

2 Рекомендовано пациентам с неосложненным эндокардитом с нормальной функцией почек.

3 Предпочтительно у пациентов старше 65 лет и с нарушениями функции почек или функции VIII

(вестибулокохлеарного) нерва
4 При длительном лечении контролировать картину периферической крови, состояния печени и почек
5 Доза гентамицина подбирается для достижения пиковой концентрации в сыворотке
6 терапия продолжается 6 недель в случае сохранения симптомов более 3 месяцев или при поражении протезированных клапанов
7 Активность в отношении E. faecalis
8 Неактивна в отношении E. faecalis

На амбулаторном уровне, с целью преемственности терапии, могут применяться и другие антибактериальные препараты, не представленные в выше определяемые в зависимости от рекомендаций, полученных на стационарном уровне.

АРНИ предпочтительнее блокаторов РААС у пациентов с эндокардитом, у которых имеется СН с низкой ФВ ЛЖ (<40%).
Бета-блокаторы, блокаторы РААС (иАПФ или сартаны), АМКР и SGLT2-ингибиторы входят в неспецифическую терапию эндокардитов и могут быть назначены всем пациентам.

Терапевтические мероприяти (дополнительное медикаментозное лечение)		Уровень и вид ПЛАНОВОЙ медицинской помощи					Средняя суточная доза	Курсовая доза
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
Название (международное непатентованное) лекарственного средства	Применение и дозировка лекарственного средства	СВП/СП	МПЦП	Районная (городская) больница	ЛПУ на уровне области	ЛПУ на уровне республики		
1. Оральные антикоагулянты[1]: - Ривароксабан - Апиксабан	- Ривароксабан 15-20 мг 1 раз в день - Апиксабан 2,5-5 мг 2 раза в день		+	+	+	+	- Ривароксабан 15-20 мг 1 раз в день - Апиксабан 2,5-5 мг 2 раза в день	Длительность терапии зависит от клинического статуса
2. Прямые антикоагулянты: - Гепарин - Эноксипарин	- Гепарин 5000 ЕД п/к 4 раза в день; - Эноксипарин 100 антиХа ЕД на 1 кг массы тела 2 раза в день			+	+	+	- Гепарин 5000 ЕД п/к 4 раза в день; - Эноксипарин 100 антиХа ЕД на 1 кг массы тела 2 раза в день	
3. Антиаритмики: - Амиодарон - Аллапинин - Пропафенон	- Амиодарон 200 мг по схеме насыщения; - Аллапинин 25 мг по 1 табл. 3 раза в день;		+	+	+	+	- Амиодарон 200 мг по схеме насыщения; - Аллапинин 25	

- Этацизин - Верапамил - Дилтиазем	- Пропафенон 150 мг по 1 табл. 3 раз в день; - Этацизин 50 мг по 1 табл. 3 раза в день; - Верапамил 80-160 мг по 1 табал. 2-3 раза в день; - Дилтиазем 90 мг по 1 табл. 2 раза в день						мг по 1 табл. 3 раза в день; - Пропафенон 150 мг по 1 табл. 3 раз в день; - Этицизин 50 мг по 1 табл. 3 раза в день; - Верапамил 80-160 мг по 1 табал. 2-3 раза в день; - Дилтиазем 90 мг по 1 табл. 2 раза в день	
4. Ивабрадин	5-7,5 мг по 1 табл. 2 раза в день		+	+	+	+	10-15 мг	
5. Триметазидин	80 мг 1 раза в день, 35 мг 2 раза в день	+	+	+	+	+	70-80 мг	
6. Ранолазин	500-1000 мг 2 раза в день	+	+	+	+	+	1000-2000 мг	
7. Петлевые диуретики: - фуросемид - торасемид	- Фуросемид 40 мг по 1 табл. 1 раз в день; - Торасемид 10 мг по 1 табл. 1 раз в день	+	+	+	+	+	- Фуросемид 40 мг по 1 табл. 1 раз в день; - Торасемид 10 мг по 1 табл. 1 раз в день	
Примечание: [1] Оральные антикоагулянты назначаются у пациентов с эндокардитом при наличии ФП.								

Терапевтические мероприятия (основное медикаментозное лечение)		Уровень и вид ЭКСТРЕННОЙ медицинской помощи					Средняя суточная доза	Курсовая доза
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
Название	Применение и	СВП/СП	МПЦП	Районная (городская)	ЛПУ на уровне	ЛПУ на уровне		

(международное непатентованное) лекарственного средства	дозировка лекарственного средства			больница	области	республики		
1. Перечень основных противомикробных препаратов имеющих 100% вероятность применения: А) Пенициллины: - Бензилпенициллина натриевая соль ампициллин Б) Цефалоспорины: - Цефазолин В) b-лактамы Амоксициллин / клавуланат Г) сульфаниламиды Ко-тримоксазол	Бензилпенициллина натриевая соль 250 000-500 000 ЕД каждые 6 часов;; Суточную дозу делят на 4-6 введений.			+	+	+	суточная доза 1.000.000-2.000.000 ЕД максимальная – 40.000.000-60.000.000 ЕД в сутки внутривенно	не менее 4-8 недель
	Ампициллин 2 г внутривенно каждые 4 часа. Цефазолин от 1 до 1,5 г в / в каждые 6 часов или 2 г в / в каждые 8 часов			+	+	+	Максимальная доза: 12 г/день Максимальная доза: 12 г/день	не менее 4-8 недель
	Амоксициллин / клавуланат В зависимости от степени тяжести инфекции, назначают 1000 мг/100 мг каждые 8 часов или 2000/200 мг			+	+	+		
	Ко-тримоксазол ➢ Сульфометоксазол 4 800 мг/день Триметоприм 960 мг/день (в/в в 4-6 введений)			+	+	+		
2. Колхицин[1]	Колхицин 0,5-1 мг по 1 табл. 1 раз в день		+	+	+	+	Колхицин 0,5-1 мг по 1 табл. 1 раз в день	3-6 месяцев
3. Глюкокортикостероиды[2]: - Преднизолон	Преднизолон 30-40 мг в сутки		+	+	+	+	Преднизолон 30-40 мг в сутки	3-6 месяцев

4. Блокаторы РААС: **А) иАПФ:** **- Эналаприл** **- Рамиприл** **- Периндоприл** **Б) БРА (сартанлар):** **- Валсартан** **- Лозартан** **- Кандесартан** **- Телмисартан** **- Азилсартан** **- Олмесартан**	**иАПФ:** **- Эналаприл 2,5-20 мг 2 раз в день** **- Рамиприл 2,5-10 мг 1 раз в день** **- Периндоприл эрбумин 2-8 мг 1 раз в день** **- Периндопил аргинин 2,5-10 мг 1 раз в день** **БРА:** **- Валсартан – 40-320 мг 2 раз в день** **- Лозартан 25-100 мг 1 раз в деь** **- Кандесартан 4-32 мг 1 раз в день** **- Телмисартан 10-80 мг 1 раз в день** **- Азилсартан 20-80 мг 1 раз в день** **- Олмесартан 10-40 мг 1 раз в день**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**иАПФ:** **- Эналаприл 2,5-20 мг** **- Рамиприл 2,5-10 мг** **- Периндоприл эрбумин 2-8 мг** **- Периндопил аргинин 2,5-10 мг** **БРА:** **- Валсартан – 40-320 мг** **- Лозартан 25-100 мг** **- Кандесартан 4-32 мг** **- Телмисартан 10-80 мг** **- Азилсартан 20-80 мг** **- Олмесартан 10-40 мг**	**Длительность терапии зависит от клинического статуса**
5. АРНИ[3]: **- Сакубитрил/Валсартан**	**24/26 мг (50 мг), 49/51 мг (100 мг) или 97/103 мг (200 мг). По 1 таблетке 2 раза в день (доза подбирается под контролем АД)**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**100-400 мг**	**Длительность терапии зависит от клинического статуса**
6. Бета-блокаторы: **- Бисопролол** **- Метопролол** **- Небивалол** **- Карведилол**	**- Бисопролол 2,5-10 мг 1 раз в день** **- Метопролол сукцинат 25-100 мг 1 раз в день** **- Небивалол 2,5-10 мг 1 раз в день** **- Карведилол 3,125-25**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**- Бисопролол 2,5-10 мг** **- Метопролол сукцинат 25-100 мг** **- Небивалол 2,5-10 мг**	**Длительность терапии зависит от клинического статуса**

	мг кунлик дозаси 2-3 раза в день						- Карведилол 3,125-25 мг	
7. Антогонисты минералокортикоидных рецепторов: - Спиронолактон - Эплеренон	- Спиронолактон 25-50 мг по 1 табл. (капс) 1 раз в день; - Эплеренон 25-50 мг по 1 табл. 1 раз в день.	+	+	+	+	+	- Спиронолак-тон 25-50 мг - Эплеренон 25-50 мг	Длительность терапии зависит от клинического статуса
8. SGLT2-ингибиторы: - Эмпаглифлозин - Дапаглифлозин	- Эмпаглифлозин 10-25 мг по 1 табл. 1 раз в день; - Дапаглифлозин 10 мг по 1 табл. 1 раз в день.	+	+	+	+	+	- Эмпаглифлозин 10-25 мг по 1 табл. 1 раз в день; - Дапаглифлозин 10 мг по 1 табл. 1 раз в день.	Длительность терапии зависит от клинического статуса

Примечание: [1] Колхицин рекомендуется использовать при эндокардитах в сочетании с перикардитами.

[2] Глюкокортикостероиды могут быть использованы при: лимфоцитарном эндокардите; гигантоклеточном эндокардите; эндокардите, ассоциированном с аутоиммунными заболеваниями; саркоидном эндокардите; аллергическом эндокардите.

[3] АРНИ предпочтительнее блокаторов РААС у пациентов с эндокардитом, у которых имеется СН с низкой ФВ ЛЖ (<40%).

Бета-блокаторы, блокаторы РААС (иАПФ или сартаны), АМКР и SGLT2-ингибиторы входят в неспецифическую терапию эндокардитов и могут быть назначены всем пациентам.

Терапевтические мероприяти (дополнительное медикаментозное лечение)		Уровень и вид ЭКСТРЕННОЙ медицинской помощи					Средняя суточная доза	Курсовая доза
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
Название (международное непатентованное) лекарственного средства	Применение и дозировка лекарственного средства	СВП/СП	МПЦП	Районная (городская) больница	ЛПУ на уровне области	ЛПУ на уровне республики		
1. Оральные антикоагулянты[1]: - Ривароксабан - Апиксабан	- Ривароксабан 15-20 мг 1 раз в день - Апиксабан 2,5-5 мг 2 раза в день		+	+	+	+	- Ривароксабан 15-20 мг 1 раз в день - Апиксабан 2,5-5 мг 2 раза в день	Длительность терапии зависит от клинического статуса
2. Прямые антикоагулянты: - Гепарин - Эноксипарин	- Гепарин 5000 ЕД п/к 4 раза в день; - Эноксипарин 100			+	+	+	- Гепарин 5000 ЕД п/к 4 раза в день; - Эноксипарин	Длительность терапии зависит от

	антиХа ЕД на 1 кг массы тела 2 раза в день						**100 антиХа ЕД на 1 кг массы тела 2 раза в день**	**клинического статуса**
2. Антиаритмики: **- Амиодарон** **- Верапамил** **- АТФ** **- Лидокаин** **- Эсмолол** **- Атропин**	**- Амиодарон 5%-3 мл в/в;** **- Верапамил 0,25%-2 мл в/в** **- АТФ 1%-1 мл в/в** **- Лидокаин 1%-2 мл в/в** **- Эсмолол 1%-1 мл в/в** **- Атропин 0,1%-1 мл п/к, в/в**		**+**	**+**	**+**	**+**	**- Амиодарон 5%-3 мл в/в;** **- Верапамил 0,25%-2 мл в/в** **- АТФ 1%-1 мл в/в** **- Лидокаин 1%-2 мл в/в** **- Эсмолол 1%-1 мл в/в** **- Атропин 0,1%-1 мл п/к, в/в**	**Длительность терапии зависит от клинического статуса**
4. Триметазидин	**80 мг 1 раза в день, 35 мг 2 раза в день**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**70-80 мг**	**Длительность терапии зависит от клинического статуса**
5. Ранолазин	**500-1000 мг 2 раза в день**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**1000-2000 мг**	**Длительность терапии зависит от клинического статуса**
6. Петлевые диуретики: **- фуросемид** **- торасемид**	**- Фуросемид 1%-2 мл в/в;** **- Торасемид 2,5%-4 мл в/в**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**- Фуросемид 40 мг по 1 табл. 1 раз в день;** **- Торасемид 10 мг по 1 табл. 1 раз в день**	**Длительность терапии зависит от клинического статуса**
7. Вазопрессоры: **- Добутамин** **- Допамин** **- Норадреналин**	**- Добутамин 2,5-10 мкг/кг/мин в/в;** **- Допамин 1-20 мкг/кг/мин в/в;** **- Норадреналин 0,05-0,3 мкг/кг/мин в/в**			**+**	**+**	**+**	**- Фуросемид 1%-2 мл в/в;** **- Торасемид 2,5%-4 мл в/в**	**Длительность терапии зависит от клинического статуса**

Примечание: [1] Оральные антикоагулянты назначаются у пациентов с эндокардитом при наличии ФП.

(ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия (оперативное лечение)	Уровень и вид ПЛАНОВОЙ/ЭКСТРЕННОЙ медицинской помощи				
	Амбулаторная помощь		Стационарная помощь		
Название оперативного (ой) вмешательства/процедуры/манипуляции	СВП/СП	МПЦП	Районная (городская) больница	ЛПУ на уровне области	ЛПУ на уровне республики
1. Санация камер сердца				+	+
2. Реконструкция клапанов сердца				+	+
3. Протезирование или репротезирование (биологическими, механическими) клапанов сердца				+	+
4. Установка временного/постоянного ЭКС			+	+	+
5. Установка ИКД				+	+
6. Установка устройства CRT				+	+
7. Радиочастотная абляция				+	+
8. Внутриаортальная баллонная контрпульсация				+	+
Примечание: Необходимость проведения хирургического вмешательства следуется определять на основе решения мультидисциплинарного консилиума.					

(ЛЕЧЕБНЫЙ СТОЛ И ДИЕТА)

Режим питания	Уровень и вид медицинской помощи				
	Амбулаторная помощь		Стационарная помощь		
Диетический стол и его продолжительность	СВП/СП	МПЦП	Районная (городская) больница	ЛПУ на уровне области	ЛПУ на уровне республики
1. Стол №10, пожизненно	+	+	+	+	+

(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ)

Мероприятия по	Название медицинских услуг	СВП/СП	МПЦП	Минимальное	Срок диспансерного

диспансеризации				количество мероприятий	наблюдения
Консультация специалистов (врачей)	1. Медсестра	+	+	- После острого неосложнённого эндокардита 1 раз - после острого осложнённого эндокардита 1 раз в месяц в течение 3 месяцев -	При остром эндокардите – 3 месяца;
	2. Семейный врач	+			
	3. Кардиолог		+		
	4. Терапевт		+		
	5. Ревматолог		+		
	6. ЛОР		+		
Примечание: Повторные осмотры рекомендуются для контроля деятельности ССС.					
Лабораторные исследования	1. Общий анализ крови	+	+	- После острого неосложнённого эндокардита 1 раз - после острого осложнённого эндокардита 1 раз в месяц в течение 3 месяцев	
	2. Общий анализ мочи	+	+		
	3. СРБ	+	+		
	4. Креатинин	+	+		
	5. АСЛО	+	+		
	6. АЛТ, АСТ, билирубин	+	+		
	7. Коагулограмма	+	+		
	8. Тропонин		+		
	9. РФ		+		
Примечание: Во время периодических осмотров могут быть назначены дополнительные лабораторые исселдования.					
Инструментальные исследования	1. ЭКГ	+	+	- После острого неосложнённого эндокардита 1 раз - после острого осложнённого эндокардита 1 раз в месяц в течение 3 месяцев	
	2. ЭХОКГ		+	По показаниям	
	3. ХМЭКГ		+		
	4. Рентгеноскопия грудной клетки		+		
Примечание: Во время периодических осмотров могут быть назначены дополнительные инструментальные исселдования.					